

Señales de alarma y riesgo suicida

Guía de cribado rápido en depresión

Estas señales orientan la decisión de derivación urgente o seguimiento más estrecho. Ninguna lista sustituye el juicio clínico ni una entrevista de riesgo estructurada.

INDICADORES DE GRAVEDAD A EVALUAR

- Ideación suicida: pensamientos recurrentes sobre la muerte o sobre hacerse daño.
- Presencia de plan concreto (método, momento, lugar) — eleva sustancialmente el riesgo.
- Anhedonia extrema: incapacidad casi total de sentir placer en cualquier área.
- Retraimiento profundo: aislamiento absoluto, abandono de higiene y responsabilidades.
- Antecedente de intento previo (predictor de riesgo más robusto disponible).
- Desesperanza marcada y sostenida en el discurso del paciente.
- Acceso a medios letales en el entorno inmediato del paciente.

ESCALERA DE PREGUNTAS SUGERIDA

1. Ideación

“¿Ha tenido pensamientos de que no vale la pena seguir viviendo?”

2. Frecuencia/intensidad

“¿Con qué frecuencia aparecen? ¿Puede dejarlos de lado o se imponen?”

3. Plan

“¿Ha pensado en cómo lo haría?”

4. Intención

“¿Siente que podría llegar a hacerlo?”

5. Acceso a medios

“¿Tiene acceso a aquello con lo que lo haría?”

CUÁNDO DERIVAR DE FORMA URGENTE

Plan concreto + acceso a medios + intención expresada = derivación psiquiátrica urgente / guardia. No dejar al paciente solo hasta asegurar acompañamiento. Documentar siempre la evaluación de riesgo realizada en la sesión.

■ Clave clínica

Preguntar directamente sobre ideación suicida no aumenta el riesgo; la evidencia muestra lo contrario. Argentina: Centro de Asistencia al Suicida, línea 135 (CABA y GBA) / 011-5275-1135 u 0800-345-1435 (resto del país), 24 hs.